

Información Paciente

Nombre : Héctor René Román Garrido

Edad : 76a 9m 2d

Dirección : Isla Lenox

Rut : 5.327.006-9

Fecha Nacto: 28/05/1948

Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2221526

Sexo : Masculino

Teléfono : 976691931

N° Epicrisis

432316

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Neurología / Neurocirugía

Fecha Ingreso : 26/02/2025 22:28

Días Estadía: 4

Unidad de Egreso : Neurología / Neurocirugía

Fecha Egreso : 02/03/2025 18:00

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Crisis convulsiva

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Ingreso CASR 26/02/25

Ingreso sala de neurología 27/02/25

Paciente diestro, mRs 1, con los siguientes antecedentes

- Médicos: Encefalitis autoinmune por anticuerpos anti Gaba B en tto con Rituximab (1° dosis agosto 2023), IAM en marzo/2024 (Stent coronario), HTA

- Farmacos:Lacosamida 100 mg c/12 h ; Amlodipino 2,5 mg c/12 h vo ; Bisoprolol 1.25 mg c / 24 horas ; Sertralina 50 mg c / 24 horas ; Atorvastatina 40 mg al día ; Aspirina 100 mg al día ; Pregabalina 75 mg cada 24 h PM ; Elcal D

- Alergias/RAMs: Lamotrigina, Clopidogrel (Rash cutáneo) ; Azatriopina (inflamación hepática)

- Qx: Colonoscopia y resección preventiva de pólipos (enero 2024) ; Cirugía aorta abdominal 2 prótesis (26.04.24).

HISTORIA:

Paciente con antecedente de encefalitis autoinmune por anticuerpos anti GABA B (Diagnóstico noviembre 2022), última crisis epiléptica hace más de dos años.

Visto por última vez en su basal a las 14:25 del 25/02 . A las 14:30 es encontrado por hija con compromiso de conciencia , asociado a postura tónica de 4 extremidades y ausencia de emisión de lenguaje, episodio habría durado aproximadamente 4 minutos. En dicho contexto se le trasladó a servicio de urgencias, en aquel momento se describe con agitación psicomotora leve y balbuceos ininteligibles . A su ingreso al servicio de urgencias se describe con potsictal de aproximadamente 90 minutos de duración con recuperación posterior del basal.

Paciente consultó nuevamente el 26/02, al interrogatorio dirigido en relación a posibles gatillantes de la crisis al momento de su reingreso el 26/02 negó historia de fiebre, síntomas respiratorios o urinarios. Destacó historia de insomnio en relación a trastorno conductual del sueño REM durante los últimos 8 meses, y suspensión de pregabalina en enero de 2025. Se solicitó TC + aTC de cerebro que no evidenció lesiones agudas. Al estudio de laboratorio sin elevación de parámetros inflamatorios, orina completa no inflamatoria, se realizó rx de tórax que no evidenció lesiones agudas. Al examen neurológico sin focalidades evidentes, solo alteración del recuerdo diferido aparentemente ya conocida, y desorientación temporal.

En base a lo anterior se planteó probable crisis convulsiva en contexto de reactivación de encefalitis autoinmune conocida. Se decidió hospitalizar para manejo con bolo de metilprednisolona y posterior administración de rituximab (Última dosis hace más de 6 meses, julio 2024)

Fecha Epicrisis : 02/03/2025 18:22

Página 1 de 3

Exámenes de ingreso

- Laboratorio 26/02/25: PCR 8.8, Glucosa 209, Crea 1.16, BUN 13.4, Calcio 9.1, Mg 2.0, Ac Láctico 29.8, INR 1.06, TTPA 24.9, ELP 138/3.58/107, Hb 14.4, Leuco 7.69, Plaq 184, GSV pH 7.25, HCO3 21.1, BE -6.1, TUS 10

Diagnósticos de ingreso

- Crisis convulsiva. Sospecha de reactivación encefalitis conocida

EVOLUCIÓN

Paciente evolucionó estable sin nuevos episodios de crisis, con cefalea leve en relación a contusión occipital que respondió de buena forma a paracetamol. Se administraron 500 mg de metilprednisolona sin incidentes el 27/02. El 28/02 se administraron 500 mg de rituximab, bien tolerados por el paciente. Se ajustó dosis de lacosamida a 150 mg c/12 hrs y se realizó RM de cerebro con gadolinio el día 01/03/2025 informándose como: Cambios de aspecto microangiopático en la sustancia blanca supratentorial, discretamente más acentuados al comparar con un estudio de diciembre de 2022.

En vista de buena evolución en condiciones de alta para continuar manejo ambulatorio con prednisona via oral en dosis descendente

Diagnóstico de Egreso

Encefalopatía No Especificada - Crisis Convulsiva Secundaria A Reactivación Encefalitis Autoinmune Conocida

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Mental: vigil, atento, invierte series simples y complejas, nomina 5/5, repite 5/5, sin disartria. Recuerdo diferido 2/4, no recupera con clave

- PC: RFM y consensuado presente, sin anisocoria, campo visual conservado por confrontación, oculomotilidad conservada. Sensibilidad facial conservada, motilidad facial simétrica, lengua protruye en línea media

- Motor: trofismo adecuado, tono conservado. A la evaluación de fuerza, con PMP (-), y grupos musculares con M5. ROT conservados, plantares flexores. Sin otros.

- Sensibilidad: sin alteraciones termoalgésicas/palísticas

- Cerebelo: sin dismetría

Plan Post Alta

Régimen hiposódico

Reposo relativo

Medicamentos:

- Prednisona 20 mg, 3 comprimidos vía oral una vez al día durante 3 días, luego 2.5 comprimidos una vez al día durante 3 días, posteriormente 2 comprimidos al día por 3 días, luego 40 mg y mantener hasta el control

- Acido acetilsalicílico 100 mg, 1 comprimido al día vía oral

- Amlodipino 10 mg, medio comprimido al día vía oral

- Atorvastatina 20 mg, 2 comprimidos durante la noche vía oral

- Bisoprolol 5 mg, 1 cuarto de comprimido una vez al día vía oral

- Sertralina 50 mg, un comprimido en la mañana vía oral

- Lacosamida 150 mg cada 12 horas vía oral

- Gabapentina 300 mg, 1 cápsula en la noche vía oral

- Omeprazol 20 mg al día, vía oral

- ElcalD 1 comprimido al día, vía oral

- Cotrimoxazol forte 1 comprimido lunes, miercoles y viernes, vía oral

Controles:

- Control con neurólogo tratante de forma ambulatoria (Dr Reinaldo Uribe, se deja IC)

- Consultar en servicio de urgencias en caso de signos de alarma

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Fecha Epicrisis : 02/03/2025 18:22



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 02-03-2025 18:22:40

Página 3 de 3

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Gonzalo Vélez Macías

Becado/Residente

Amada Marcela Espinosa Maramb

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 02/03/2025 18:22

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:19

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar